

**PROTOCOLO DE ACESSO
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA (ADULTO)**

Versão 1.0 – 2026





MISSÃO

“Promover saúde e bem-estar para as pessoas.”



VISÃO

“Ser uma instituição ágil e inovadora, atenta as necessidades de integralidade e sustentabilidade, referência em gestão de saúde pública no Brasil.”

VALORES



Orgulho e Paixão

Transparência

Empatia e Cuidado

Eficiência e Inovação

Sustentabilidade e Governança



PREFEITA

Rejane Gambin

SECRETÁRIA DA SAÚDE

Daniela Aparecida Gregório França Cavalcante

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Jocelita Cardozo Colagrande

DIRETORIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vanessa Cardoso Pacheco

DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Aline Gabrielle de Souza Berkenbrock

DIRETORIA DE GESTÃO JURÍDICA E ORGANIZACIONAL

Marcianita Lopata de Lima

DIRETORIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Amanda Nunes

DIRETORIA TÉCNICA

Luana Garcia Ferrabone

DIRETORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE

Sheila Batista de Araújo

DIRETORIA DE VIGILÂNCIAS

Maria Cristina Antunes Willemann

GERÊNCIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann – Distrito Leste

Grasiela Florencio Medeiros – Distrito Norte

Gislaine Batista de Souza – Distrito Sul

Maristela Mello de Aguiar - Distrito Oeste

GERÊNCIA DE QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Juliana Antunes Safanelli

GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E LABORATÓRIO MUNICIPAL

Johnattan Curcio

GERÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Franci Maiara Machado

GERÊNCIA TÉCNICA DE ODONTOLOGIA

Rayane Alexandra Prochnow

GERÊNCIA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Nádia Cristina Brach



GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Jaqueline Fornari

GERÊNCIA DE REGULAÇÃO

Flaviane Andrzejewski

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DA QUALIDADE E PROCESSOS

Cibely Schipitoski Borges

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

REVISÃO

Mauricio Jose Rodrigues Mandalis

Thais Camile Bauer de Oliveira

ELABORAÇÃO/COLABORAÇÃO

Jhoselin Paula Alves Carone Rachid

Nicole Schulka

Michelli Aparecida Rosin

Fabiane Voss



SUMÁRIO

1.INTRODUÇÃO.....	8
2.ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA).....	10
2.1 Objetivos clínicos e diagnósticos.....	10
2.2 Potencial terapêutico.....	10
2.3 Indicações clínicas e critérios de acesso.....	10
2.3.1 Dispepsia.....	10
2.3.2 Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE).....	11
2.3.3 Suspeita de neoplasia maligna do aparelho gastrointestinal.....	11
2.3.4 Investigação de anemia ferropriva.....	11
2.3.5 Controle de úlcera gástrica (8 a 12 semanas após tratamento de erradicação do h. pylori).....	12
2.3.6 Seguimento do paciente com metaplasia gastrintestinal.....	12
2.3.7 Avaliação de hipertensão portal - varizes esofágicas.....	12
2.4 Profissionais requisitantes.....	13
2.5 Requisitos mínimos para o encaminhamento.....	13
2.6 Matriz de Estratificação de Risco para Procedimentos Endoscópicos (Adulto)	14
3.COLONOSCOPIA.....	15
3.1 Objetivos clínicos e diagnósticos.....	15
3.2 Potencial terapêutico.....	15
3.3 Indicações clínicas e critérios de acesso.....	16
3.3.1 Suspeita de Neoplasia Colorretal (Sinais de alarme).....	16
3.3.2 Rastreamento câncer colorretal.....	16
3.3.3 Vigilância e Acompanhamento.....	16
3.3.4 Outras condições clínicas.....	17
3.4 Profissionais requisitantes.....	18
3.5 Requisitos mínimos para o encaminhamento.....	18
3.6 Matriz de estratificação de risco para colonoscopia (adulto).....	19
4.CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR.....	20
5.CRITÉRIOS DE EMERGÊNCIA (ENCAMINHAMENTO IMEDIATO).....	21
REFERÊNCIAS.....	22



LISTA DE TABELAS

Tabela 01 - Conferência para encaminhamento para endoscopia (checklist obrigatório)..	13
Tabela 02 - Matriz de estratificação de risco para procedimentos endoscópicos (adulto).	14
Tabela 3 - Acompanhamento de lesões pré-malignas em topografia colorretal com colonoscopia.....	17
Tabela 04 - Tabela de conferência para encaminhamento para colonoscopia (Checklist Obrigatório).....	18
Tabela 05 - Matriz de estratificação de risco para procedimentos de colonoscopia (adulto).	19



LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

- APS** – Atenção primária à saúde
ACO - Anticoncepcionais orais combinados
AINES - Anti-inflamatórios não esteroides
DII – Doenças Inflamatórias Intestinais
DPOC – Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica
DRGE – Doença do Refluxo Gastroesofágico
EDA – Endoscopia Digestiva Alta
HB – Hemograma
HDA - Hemorragia digestiva alta
IBP - Inibidores de bomba de prótons
IMC – Índice de Massa Corporal
Kg - Kilograma
MALT - Tecido linfóide associado à mucosa
NGQP - Núcleo de Gestão e Qualidade de Processos
OLGA - *Operative Link on Gastritis Assessment* – OLGA" - Ligação Operacional na Avaliação da Gastrite (OLGA).
PSO – Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes
RAS – Rede de Atenção à Saúde
SES/SC - Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina
SUS – Sistema Único de Saúde
UPA – Unidade de Pronto Atendimento
VCM – Volume Corpuscular Médio
VSAD - Sistematização de sintomas de alerta (vômitos, sangramento, massa e disfagia)



1.INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei nº 8.080/1990, garante o acesso universal, integral e equitativo às ações e serviços de saúde. A Política Nacional de Regulação, estabelecida pela Portaria GM/MS nº 1.559/2008, orienta a regulação em três dimensões: Regulação dos Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação da Assistência à Saúde.

A regulação assistencial, ou regulação do acesso, consiste na disponibilização da alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, de forma ordenada, oportuna, qualificada e equânime, sendo um instrumento fundamental para a organização da Rede de Atenção à Saúde (RAS). Por meio do processo regulatório, promove-se a resolução de casos que exigem ações articuladas em diferentes pontos de atenção, favorecendo a gestão racional dos recursos, a identificação de áreas críticas e a otimização do atendimento.

Considerando que os protocolos de acesso são instrumentos de ordenação dos fluxos de encaminhamento, que qualificam o acesso e viabilizam a atenção integral ao paciente, orientando quanto à competência dos níveis de atenção.

A Endoscopia digestiva alta (EDA) e a colonoscopia representam, hoje, os pilares fundamentais da gastroenterologia moderna. Mais do que simples exames de imagem, esses procedimentos são ferramentas vitais que permitem a visualização direta da mucosa do trato gastrointestinal, possibilitando um diagnóstico de precisão que exames laboratoriais ou radiológicos convencionais muitas vezes não conseguem alcançar.

A implementação de protocolos EDA e a colonoscopia em pacientes adultos é um passo estratégico para a consolidação de uma rede de saúde eficiente e equânime. Assim como ocorre com outros exames de alta complexidade, os procedimentos endoscópicos são recursos tecnológicos fundamentais que exigem uma gestão criteriosa para que sua oferta no SUS atenda a quem realmente necessita, no tempo clínico adequado.

A adequada organização e otimização do acesso aos exames especializados contribuem para protocolos mais claros e intuitivos para os profissionais de saúde, além de melhor direcionamento às reais necessidades dos pacientes.

As subdivisões específicas para cada condição clínica facilitam o processo de solicitação e sua estratificação dentro do exame, permitindo um acesso mais rápido e eficiente ao exame correto, o que reduz erros e permite otimizar recursos, além de padronizar o fluxo de solicitações e fortalecer a integridade do processo de regulação.



A regulação municipal desempenha um papel estratégico na ordenação e priorização do acesso à EDA e a colonoscopia, fundamentando-se em critérios de classificação de risco e na urgência clínica. Esta estrutura regulatória é indispensável para viabilizar o atendimento em tempo oportuno, mitigando o risco de progressão de patologias tempo-dependentes que, se não diagnosticadas precocemente, podem comprometer severamente o prognóstico do paciente.

O manejo criterioso desses recursos tecnológicos é o que sustenta um acesso equânime e qualificado no SUS. Ao promover a atualização contínua dos critérios de agendamento, o protocolo oferece aos profissionais de saúde diretrizes claras e baseadas em evidências para a tomada de decisão. Essa padronização potencializa a resolutividade na interface entre a Atenção Primária e a Atenção Especializada, consolidando uma rede de assistência eficaz, humanizada e ágil, voltada à entrega de valor e saúde para toda a comunidade.

Ademais, este protocolo visa nortear a tomada de decisão dos médicos reguladores, fomentando uma cultura onde o encaminhamento à atenção especializada ocorra estritamente por critérios de necessidade clínica. Este fluxo pressupõe que a Atenção Primária à Saúde (APS) tenha exaurido sua capacidade resolutiva para o caso, sem, contudo, transferir sua responsabilidade técnica: a APS permanece como a coordenadora do cuidado e o centro ordenador da rede, garantindo o acompanhamento longitudinal e a continuidade da assistência ao usuário após a realização do procedimento especializado.



2.ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA)

A Endoscopia Digestiva Alta é um procedimento diagnóstico e, frequentemente, terapêutico, que permite a exploração visual da mucosa do trato digestivo superior, abrangendo o esôfago, o estômago e o duodeno (até a sua segunda porção).

2.1 Objetivos clínicos e diagnósticos

O exame é o padrão-ouro para a investigação de sintomas relacionados ao trato superior, permitindo identificar:

- Doenças inflamatórias e ulcerosas: Esofagites, gastrites, duodenites e úlceras gástricas ou duodenais.
- Neoplasias: Detecção precoce de câncer de esôfago e estômago, além de lesões pré-malignas (como o Esôfago de Barrett).
- Distúrbios estruturais: Hérnias de hiato, estenoses (estreitamentos) e varizes esofágicas.
- Pesquisa de *Helicobacter pylori*: Realização de teste de urease ou biópsia para identificação da bactéria associada a úlceras e câncer gástrico.

2.2 Potencial terapêutico

Diferente de exames de imagem radiológicos, a EDA permite intervenções imediatas que podem evitar cirurgias invasivas:

- Hemostasia: Interrupção de sangramentos ativos (úlceras sangrantes ou varizes).
- Polipectomia: Remoção de pólipos gástricos.
- Dilatações: Tratamento de estreitamentos esofágicos.
- Retirada de corpos estranhos: Remoção de objetos ou alimentos impactados.

2.3 Indicações clínicas e critérios de acesso

2.3.1 Dispepsia

- Falha Terapêutica: Sintomas persistentes após tratamento otimizado (IBP- inibidor de bomba de prótons- em dose plena por 8 semanas + erradicação de *H. pylori* confirmada).
- Idade de corte: Dispepsia de início recente em pacientes com 60 anos ou mais.



- Triagem cardiovascular: Sintomas dispépticos em pacientes com indicação iminente ou em uso de terapia antiplaquetária/anticoagulante.
- Dispepsia com sinais de alarme:
 - V: vômitos;
 - S: sangramento ou anemia;
 - A: massa abdominal ou perda de peso não intencional;
 - D: disfagia.
- Dispepsia em pacientes com indicação de iniciar terapia antiplaquetária ou anticoagulação ou pacientes em uso de anticoncepcionais orais combinados (ACO) e sintomas dispépticos.

2.3.2 Doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)

- DRGE não controlado com tratamento otimizado (medidas comportamentais, inibidor da bomba de prótons em dose plena) por 2 meses;
- Acompanhamento de Esôfago de Barrett; Sinais de Alarme (sistematização VSAD):
 - V: Vômitos persistentes.
 - S: Sangramento visível ou Anemia ferropriva comprovada.
 - A: Massa abdominal palpável ou Perda Ponderal não intencional.
 - D: Disfagia ou Odinofagia progressiva.

2.3.3 Suspeita de neoplasia maligna do aparelho gastrointestinal

Sinais de alarme: disfagia esofágica, odinofagia, emagrecimento, vômitos persistentes, sangramento crônico gastrointestinal ou anemia por deficiência de ferro sem causa presumível, massa epigástrica.

2.3.4 Investigação de anemia ferropriva

A indicação da EDA na investigação da anemia ferropriva fundamenta-se na alta prevalência de patologias do trato gastrointestinal superior como causas primárias de perda hemática crônica ou déficit de absorção. Do ponto de vista etiológico, a EDA permite o diagnóstico de lesões ulcerosas, erosivas e vasculares (como ectasias e úlceras de Cameron) que causam sangramento oculto e persistente. Além disso, o exame é essencial para o rastreamento precoce de neoplasias gástricas e esofágicas, frequentemente assintomáticas em estágios iniciais, exceto pela ferropenia. (ASGE,2021)



2.3.5 Controle de úlcera gástrica (8 a 12 semanas após tratamento de erradicação do *H. pylori*)

A reavaliação endoscópica de úlceras gástricas é mandatória para confirmar a cicatrização da lesão e excluir a possibilidade de malignidade (adenocarcinoma gástrico ou linfoma - Tecido linfóide associado à mucosa (MALT)), que pode mimetizar uma úlcera benigna em exames iniciais. A persistência da lesão após o tratamento de erradicação do *H. pylori* e terapia com inibidores de bomba de prótons (IBP) exige novas biópsias para diagnóstico diferencial.

2.3.6 Seguimento do paciente com metaplasia gastrintestinal

A metaplasia intestinal gástrica é uma lesão precursora no processo de carcinogênese gástrica (cascata de correa). O seguimento endoscópico sistemático, com biópsias orientadas (conforme o sistema de estadiamento OLGA/OLGIM) ou seja *Operative Link on Gastritis Assessment – OLGA* - Ligação operacional na avaliação da gastrite (OLGA), que é indicado para o monitoramento de pacientes com maior risco de progressão para displasia e adenocarcinoma, permitindo intervenções terapêuticas minimamente invasivas em caso de neoplasia precoce.

O monitoramento contínuo de condições pré-neoplásicas está alinhado à **Política Nacional de Atenção Oncológica**. A vigilância periódica assegura o direito fundamental à saúde mediante a utilização de protocolos de vigilância epidemiológica e clínica, visando a redução da morbimortalidade por câncer.

- Sem displasia: A cada 3 anos.
- Displasia de Baixo Grau: Anual.
- Displasia de Alto Grau: Repetir em 6 meses com mapeamento (múltiplas biópsias); avaliar ressecção endoscópica.

2.3.7 Avaliação de hipertensão portal - varizes esofágicas

A EDA é o padrão-ouro para o rastreamento, classificação e estratificação de risco de ruptura de varizes esofágicas e gástricas em pacientes com cirrose ou hipertensão portal de outras etiologias. A identificação de varizes de médio/grosso calibre ou a presença de "sinais de cor vermelha" (*red spots*) fundamenta a indicação de profilaxia primária (farmacológica ou ligadura elástica) para prevenir a hemorragia digestiva alta (HDA).



2.4 Profissionais requisitantes

Médicos da atenção primária e médicos de outras especialidades

2.5 Requisitos mínimos para o encaminhamento

O médico solicitante deve obrigatoriamente informar no sistema de regulação:

- Quadro clínico: descrição detalhada de sinais, sintomas e achados do exame físico;
- Laboratório (anemias), resultados de hemograma (HB), volume corpuscular médio (VCM), ferro e ferritina, além do pso (incluir datas);
- Dados antropométricos: se houver perda de peso, quantificar em quilos e tempo (ex: 5kg em 2 meses);
- Exames prévios: informar se é o primeiro exame ou anexar laudo de EDA/Colonoscopia ou Biópsias anteriores.
- Listar medicamentos em uso (especialmente anticoagulantes/ anti-inflamatórios não esteroides - AINES) e descrever tratamentos prévios realizados para a queixa atual;
- Histórico familiar: Câncer gástrico/colorretal em parentes de 1º grau + idade. (especificar idade do diagnóstico),
- Relatar comorbidades, alergias medicamentosas e histórico de reações a anestésicos.

Tabela 01 - Conferência para encaminhamento para endoscopia (checklist obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de alarme	Descrever presença de disfagia, perda de peso (kg/tempo) ou massas.	Determinar a classificação vermelha.
Dados laboratoriais	Hb, VCM, cinética de ferro e sangue oculto (PSO).	Diferenciar anemia ferropriva de outras etiologias.
Tratamento prévio	Droga utilizada, dose e tempo de uso (mínimo 8 semanas).	Evitar exames desnecessários em casos de subdosagem.
Histórico de imagem	Laudo de	Essencial para seguimento



	EDA/Colonoscopia ou biópsias anteriores.	de metaplasia e Barrett.
Perfil de risco	Idade, índice de massa corporal (IMC), comorbidades e uso de anticoagulantes.	Definir se o exame será ambulatorial ou hospitalar.
Alergias	Histórico de reações a anestésicos ou medicamentos.	Garantir a segurança durante a sedação.

Elaborado por: Núcleo de Gestão de Qualidade e Processos (NGQP), 2026.

2.6 Matriz de estratificação de risco para procedimentos endoscópicos (adulto)

Tabela 02 - Matriz de estratificação de risco para procedimentos endoscópicos (adulto)

Classificação	Crítérios de Indicação e Gravidade
VERMELHO	Alta suspeita de câncer gastrointestinal, disfagia esofágica, odinofagia, emagrecimento, vômitos persistentes, sangramento crônico gastrointestinal ou anemia ferropriva sem causa presumível, presença de massa epigástrica. Sinais de alarme em dispepsia, vômitos, sangramento, anemia, massa abdominal, perda de peso, disfagia. Uso de anticoagulantes: Indicação de início ou uso atual com sintomas dispépticos associados.
AMARELO	Investigação Clínica: Anemia, diarreia crônica, doença celíaca ou dor torácica de diagnóstico diferencial. Monitoramento de lesões: Esôfago de Barrett, metaplasia intestinal, esofagite erosiva (graus C e D). Preparo e pós-operatório: Pré-operatório de gastroplastia ou pós-operatório em paciente sintomático. Rastreamento específico: Hipertensão portal/varizes esofagianas; paciente > 60 anos com dispepsia recente ou muito sintomático (dor intensa).
VERDE	Controle pós-tratamento: Úlcera gástrica (8-12 semanas), sintomas persistentes após tratamento de úlcera, esofagite eosinofílica ou candidíase esofágica. Refratariedade: DRGE ou dispepsia sem resposta ao tratamento otimizado. Fatores de risco: História familiar (1º grau), idade > 50 anos, uso crônico de AINEs, doenças sistêmicas (esclerodermia) ou pesquisa de sangue oculto (PSO) positiva.
AZUL	Controle de manutenção: Acompanhamento de doença celíaca e confirmação de erradicação de H. pylori após tratamento.



Fonte: Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina (SES/SC), 2024.

3.COLONOSCOPIA

A colonoscopia constitui o padrão-ouro para a avaliação endoscópica integral do cólon, reto e porção distal do íleo terminal, oferecendo acurácia diagnóstica superior na análise da mucosa intestinal (ASGE, 2021). Diferente de métodos meramente diagnósticos, a colonoscopia possui caráter preventivo e terapêutico simultâneos: permite a identificação e a polipectomia de lesões precursoras. A remoção imediata desses adenomas e pólipos serrilhados interrompe a sequência adenoma-carcinoma, alterando favoravelmente a história natural da doença e reduzindo drasticamente a incidência e a mortalidade por câncer colorretal — CCR (INCA, 2021; SOBED, 2022). Pela sua capacidade de intervenção direta e visualização detalhada, o procedimento é o pilar central das estratégias de rastreamento e vigilância oncológica (REX et al., 2017).

3.1 Objetivos clínicos e diagnósticos

O procedimento é essencial para investigar:

- Alterações do hábito intestinal: Diarréia crônica ou constipação de início recente e sem causa explicada.
- Sangramento gastrointestinal: Presença de sangue vivo nas fezes (hematoquezia) ou pesquisa de sangue oculto positiva.
- Doenças inflamatórias intestinais (DII): Diagnóstico e monitoramento de Retocolite Ulcerativa e Doença de Crohn.
- Anemia ferropriva: Investigação de perda sanguínea crônica pelo trato digestivo baixo, especialmente em idosos.
- Rastreamento: Exame de rotina em pacientes acima de 45 anos ou com histórico familiar de câncer de cólon.

3.2 Potencial terapêutico

A colonoscopia evita intervenções cirúrgicas maiores ao permitir:

- Biópsias: Coleta de material para análise histopatológica.
- Mucosectomias: Retirada de lesões planas ou sésseis mais complexas.
- Controle de hemorragias: Tratamento de angiodisplasias ou sangramentos diverticulares.
- Descompressão: Tratamento de volvo (torção) de cólon ou pseudo-obstrução em



casos específicos.

3.3 Indicações clínicas e critérios de acesso

3.3.1 Suspeita de neoplasia colorretal (sinais de alarme)

Encaminhamento prioritário para pacientes que apresentem:

- Hemorragia digestiva baixa: Sangramento retal ou hematoquezia sem causa orificial óbvia;
- Alteração do hábito Intestinal: Mudança persistente no padrão evacuatório (diarreia ou constipação de início recente);
- Sintomas obstrutivos ou locais: Dor abdominal/retal persistente, tenesmo ou presença de massa palpável em topografia colônica;
- Manifestações sistêmicas: Anemia ferropriva sem causa presumível ou perda ponderal não intencional.

3.3.2 Rastreamento câncer colorretal

- Rastreamento populacional: Indicado para adultos de 50 a 75 anos, a cada 10 anos. Caso o PSO seja positivo, a colonoscopia é mandatória;
- Pacientes idosos (76 a 85 anos): A indicação deve ser individualizada, considerando a expectativa de vida, condições clínicas (comorbidades) e o histórico de exames anteriores;
- Histórico familiar: colonoscopia aos 40 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do familiar mais jovem;
- Suspeita de síndromes genéticas: Polipose Adenomatosa Familiar ou Síndrome de Lynch.

3.3.3 Vigilância e acompanhamento

- Pós-intervenção endoscópica: Controle após 6 meses de polipectomias complexas ou mucosectomias.
- Doenças inflamatórias intestinais (DII): Diagnóstico, estadiamento e vigilância de câncer em pacientes com Retocolite Ulcerativa ou Doença de Crohn.
- Lesões pré-malignas: Vigilância periódica de pólipos adenomatosos conforme o grau de displasia e tamanho da lesão.



Tabela 3 - Acompanhamento de lesões pré-malignas em topografia colorretal com colonoscopia

Lesões pré-malignas de menor potencial neoplásico	Periodicidade recomendada para colonoscopia (anos)
Pólipos hiperplásicos pequenos (< 10mm) no reto ou sigmoide	10
1 a 2 adenomas tubulares pequenos (< 10mm)	5 a 10
Lesões pré-malignas de maior potencial neoplásico	Sugerido acompanhamento em serviço especializado. Periodicidade recomendada (anos).
3 a 10 adenomas tubulares	3
> 10 adenomas	<3
≥ 1 adenoma tubular ≥ 10mm	3
≥ 1 adenoma viloso	3
Adenoma com displasia de alto grau	3
Pólipo serrátil séssil < 10mm sem displasia	5
Pólipo serrátil ≥10mm ou com displasia	3
Síndrome de polipose serrátil*	1
Fatores de maior risco: Os fatores relacionados com maior risco de câncer colorretal são: tamanho do pólipo > 1cm; padrão histológico viloso e presença de displasia de alto grau. *Síndrome de polipose serrátil: ≥ 5 pólipos serráteis proximais ao sigmoide com pelo menos 2 ≥ 10mm; qualquer pólipo serrátil proximal ao sigmoide com história familiar de síndrome de polipose serrátil; 20 pólipos serráteis de qualquer tamanho no cólon.	

Fonte: SES/SC, 2024.

3.3.4 Outras condições clínicas

- Investigação de diarreia crônica e anemia ferropriva de etiologia obscura.
- Avaliação de doença diverticular (quando houver necessidade de diagnóstico diferencial ou complicações).
- Planejamento cirúrgico de fístulas e investigação de incontinência fecal.



3.4 Profissionais requisitantes

Médicos da atenção primária e médicos de outras especialidades

3.5 Requisitos mínimos para o encaminhamento

Para que a regulação ocorra de forma eficiente, o médico solicitante deve registrar:

- Quadro clínico: Descrição dos sinais, sintomas e achados ao exame físico (ex: toque retal), informar perda ponderal quantificada (kg/tempo);
- Laboratório (anemias): resultados laboratoriais de anemia (Hb, VCM, Ferro, Ferritina e PSO com datas);
- Dados antropométricos: se houver perda de peso, quantificar em quilos e tempo (ex: 5kg em 2 meses);
- Histórico familiar e pessoal: parentesco de 1º grau com neoplasia colorretal ou pólipos de alto grau; laudos de colonoscopias e biópsias anteriores, com data (se houver. Se é primeiro exame, informar);
- Farmacoterapia: informar uso ou indicação iminente de antiplaquetários/anticoagulantes; descrever tratamentos já realizados para a condição intestinal atual (dose e tempo);
- Segurança do paciente: listar doenças de base e medicamentos em uso contínuo; relatar alergias medicamentosas ou reações prévias a anestésicos/sedação.

Tabela 04 - Tabela de conferência para encaminhamento para colonoscopia (Checklist Obrigatório)

Item de avaliação	Informação necessária (Obrigatório)	Justificativa para a Regulação
Sinais de Alarme	Descrever presença de perda de peso (kg/tempo) ou massas palpáveis.	Determinar a classificação Vermelha.
Dados Laboratoriais	Hb, VCM, Cinética de Ferro e Sangue Oculto (PSO).	Diferenciar anemia ferropriva de outras etiologias.
Histórico Familiar	Parentesco de 1º grau com neoplasia colorretal ou pólipos de alto grau.	Definir prioridade em pacientes assintomáticos.
Tratamento Prévio	Droga utilizada, dose e	Evitar exames



	tempo de uso.	desnecessários em casos de subdosagem.
Histórico de Imagem	Laudo de colonoscopia ou biópsias anteriores.	Permitir a comparação evolutiva e evitar a duplicidade de exames em intervalos inadequados.
Perfil de Risco	Idade, IMC, comorbidades e uso de anticoagulantes.	Defina se o exame será clínico ou hospitalar.
Alergias	Histórico de reações a anestésicos ou medicamentos.	Garante a segurança durante a sedação.

Elaborado por: NGQP,2026.

3.6 Matriz de estratificação de risco para colonoscopia (adulto)

Tabela 05 - Matriz de estratificação de risco para procedimentos de colonoscopia (adulto)

Classificação	Critérios de Indicação e Gravidade
VERMELHO	Suspeita de neoplasia, forte suspeita de câncer colorretal com presença de sinais de alarme (perda de peso, massa palpável). Doença inflamatória intestinal (DII), pacientes com DII em fase de atividade/crise. Sangramento ativo, enterorragia (sangramento vivo e volumoso pelo reto).
AMARELO	Investigação clínica, diarreia crônica ou anemia ferropriva, ambas de etiologia desconhecida e sem sinais de alarme imediatos. Doença diverticular com episódios de diverticulite de repetição; Pré-operatório de fístulas. Controle pós-procedimento, seguimento após polipectomia ou mucosectomia complexa.
VERDE	Rastreamento de médio risco em pacientes assintomáticos com histórico familiar (HMF) de câncer colorretal, Polipose Adenomatosa Familiar ou suspeita de Síndrome de Lynch. Acompanhamento de lesões pré-malignas (pólipos adenomatosos) e investigação de incontinência fecal.
AZUL	Pacientes assintomáticos de baixo risco (população geral na faixa etária de screening).

Fonte: SES/SC, 2024.



4.CRITÉRIOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS EM AMBIENTE HOSPITALAR

Devido ao maior risco de intercorrências durante a sedação ou o procedimento, os exames de EDA e Colonoscopia devem ser realizados obrigatoriamente em âmbito hospitalar para os seguintes perfis:

- Faixa Etária: Pacientes acima de 75 anos.
- Perfil Clínico de Risco:
 - Cardiopatias: Pacientes com insuficiência cardíaca, arritmias graves ou histórico de infarto.
 - Pneumopatias: Asma não controlada ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) dependente de oxigênio.
 - Obesidade: IMC > 35 (Obesidade Grau II e III).
 - Coagulopatias: Pacientes em uso de anticoagulantes sem possibilidade clínica de suspensão da medicação.



5.CRITÉRIOS DE EMERGÊNCIA (ENCAMINHAMENTO IMEDIATO)

As situações abaixo não devem aguardar regulação eletiva. O paciente deve ser estabilizado e encaminhado diretamente a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Emergência Hospitalar:

- Hemorragia digestiva alta aguda: Evidência de hematêmese (vômito com sangue) ou melena (fezes negras com odor fétido).
- Ingestão de corpo estranho ou agentes cáusticos: Risco iminente de perfuração ou estenose.
- Impactação alimentar e disfagia aguda grave: Impossibilidade de deglutir saliva ou secreções, associada a desconforto intenso.



REFERÊNCIAS

AHNEN, D. J.; MACRAE, F. A. **Colorectal cancer**: epidemiology, risk factors, and protective factors. Waltham, MA: UpToDate, 2015. Disponível em: <https://lifewithnogallbladder.org/article/colorectal-cancer-epidemiology-risk-factors-and-protective-factors/>. Acesso em: 10 mar. 2026.

AMERICAN SOCIETY FOR GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY. The role of endoscopy in the management of iron deficiency anemia. **Gastrointestinal Endoscopy**, [s. l.], v. 94, n. 3, p. 479-488, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria GM/MS nº 1.559, de 1º de agosto de 2008**: institui a Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2008. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2008/prt1559_01_08_2008.html. Acesso em: 27 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos do sistema de regulação**: volume III: gastroenterologia e proctologia. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Diretrizes para a detecção precoce do câncer colorretal**. Rio de Janeiro: INCA, 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 27 jan. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **Resolução CFM nº 2.174/2017**: dispõe sobre as normas de segurança na prática de anestesia. Brasília: CFM, 2017.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. **Deteção precoce do câncer colorretal**. Rio de Janeiro: INCA, 2021. Disponível em: <https://www.inca.gov.br>. Acesso em: 27 jan. 2026.

MALFERTHEINER, P. et al. Management of helicobacter pylori infection: the Maastricht VI/Florence consensus report. **Gut**, v. 71, n. 9, p. 1724-1762, 2022.

REX, D. K. et al. Colorectal cancer screening: recommendations for physicians and patients from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer. **Gastroenterology**, [s. l.], v. 153, n. 1, p. 307-323, 2017.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Protocolo de endoscopia digestiva alta e colonoscopia do estado de Santa Catarina**. Florianópolis: SES/SC, 2024. Disponível em: <https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/regulacao/protocolo-de-acesso-e-classificacao-d-e-risco/endoscopia-digestiva-alta-colonosopia-procedimentos-endoscopicos-adulto/download>. Acesso em: 27 jan. 2026.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. **Compêndio de endoscopia digestiva**. São Paulo: Atheneu, 2020.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. **Preparo de cólon para colonoscopia**. São Paulo: SOBED, 2022.



SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. **Recomendações SOBED:** rastreamento do câncer colorretal. São Paulo: SOBED, 2023.

